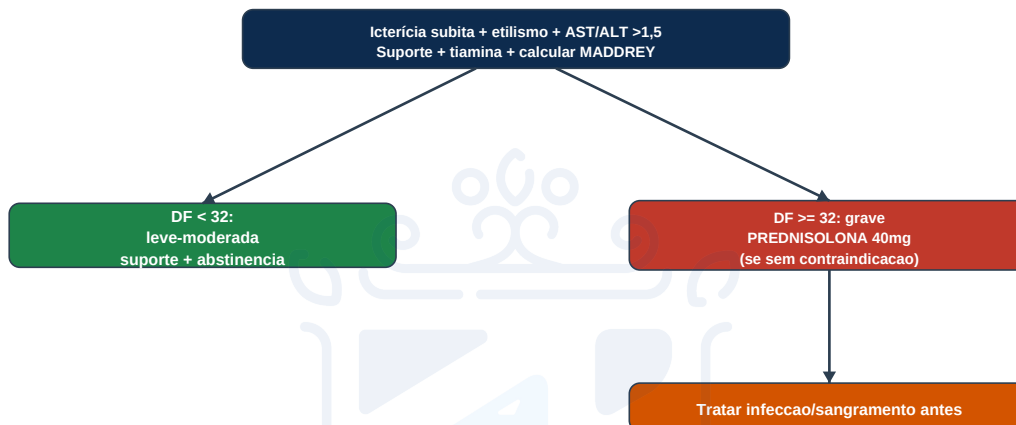


HEPATITE ALCOÓLICA AGUDA — MADDREY

FLUXOGRAMA — GRAVIDADE PELO MADDREY

HEPATITE ALCOÓLICA — CALCULAR MADDREY SEMPRE



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Síndrome inflamatória hepática aguda associada a consumo excessivo e recente de álcool
- Icterícia de início súbito + AST desproporcional à ALT (AST/ALT > 1,5, em geral < 300 U/L)
- Graus variáveis de insuficiência hepática
- Contexto: etilismo crônico pesado, ingestão recente (até 8 semanas), desnutrição

QUANDO SUSPEITAR

ANAMNESE E EXAME

- Quantidade/padrão e duração do etilismo; data da última ingestão; episódios prévios
- Icterícia, hepatomegalia DOLOROSA, febre
- Sinais de descompensação: ascite, encefalopatia hepática, hipertensão portal
- Evitar medicamentos hepatotóxicos; investigar uso concomitante de drogas
- AST/ALT > 1,5 com transaminases geralmente < 300 é a assinatura laboratorial

GRAVIDADE — DISCRIMINANTE DE MADDREY (DF)

CÁLCULO OBRIGATÓRIO

- $DF = 4,6 \times (TP \text{ do paciente} - TP \text{ controle}) + \text{bilirrubina total (mg/dL)}$
- DF < 32: hepatite alcoólica leve a moderada
- DF >= 32: hepatite alcoólica GRAVE (alta mortalidade em 28 dias)
- Critério fundamental para considerar corticoide
- O Maddrey é OBRIGATÓRIO em todo paciente com suspeita de hepatite alcoólica aguda

EXAMES

SOLICITAR

- AST, ALT, bilirrubina total e frações, INR/TP, albumina
- Creatinina, ureia, hemograma, eletrólitos
- Ultrassonografia abdominal com Doppler
- HBsAg e Anti-HCV (excluir hepatites virais)
- Rastrear infecção (frequente e contraindica corticoide se não controlada)

TRATAMENTO NO PS

Rx SUPORTE + VITAMINOTERAPIA

Suspensão IMEDIATA do álcool; suporte clínico e hemodinâmico; correção hidroeletrólítica
SF 0,9% 500-1000 mL conforme volemia
TIAMINA 100mg IV 1x/dia ANTES da glicose (prevenir Wernicke)
Complexo B 1 ampola IV/dia + Ácido fólico 5mg VO/dia
Omeprazol 40mg IV/dia; Lactulose 20-30mL 8/8h se encefalopatia
Dipirona 1g IV 6/6h se dor/febre. EVITAR AINE e PARACETAMOL; suporte nutricional precoce

CORTICOIDE — INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÕES

PREDNISOLONA NA FORMA GRAVE

- Indicação: hepatite alcoólica GRAVE (Maddrey ≥ 32) sem contraindicações
- Esquema: Prednisolona 40mg VO 1x/dia por 28 dias
- Contraindicações ABSOLUTAS: infecção ativa não controlada, sangramento digestivo ativo
- insuficiência renal grave, sepse, pancreatite aguda
- Tratar precocemente infecções antes/junto; reavaliar resposta (escore de Lille ~dia 7)

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: Maddrey ≥ 32 , bilirrubina > 3 , INR $> 1,5$, encefalopatia, insuficiência renal, infecção associada
- ☐ ALTA: clinicamente estável, sem encefalopatia, função renal preservada, sem infecção ativa
- ☐ ALTA: seguimento ambulatorial garantido (hepatologia)
- ☐ Casa: tiamina 100mg VO/dia, ácido fólico 5mg/dia, lactulose se necessário
- ☐ Abstinência alcoólica absoluta + dieta hipercalórica/hiperproteica; retorno se confusão/vômitos/sangramento

MODELO DE ENCAMINHAMENTO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Hepatite alcoólica aguda; Maddrey = ____ (≥ 32 grave). Bilirrubina ____; INR ____.
- Critérios de gravidade: encefalopatia / insuficiência renal / sangramento / instabilidade.
- Condutas: suporte, vitaminoterapia (tiamina/complexo B/folato), avaliação para corticoide.
- Solicito transferência para hospital com suporte em hepatologia e/ou UTI.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente etilista com icterícia súbita, AST 180 / ALT 90, bilirrubina 12, Maddrey 40, sem infecção/sangramento. Qual a conduta específica?

- A) Apenas suporte, sem corticoide
- B) Prednisolona 40 mg/dia por 28 dias (hepatite alcoólica grave sem contraindicações)
- C) Paracetamol para a febre
- D) Antibiótico profilático de rotina
- E) Transplante hepático imediato no PS

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual relação laboratorial é característica da hepatite alcoólica aguda?

- A) ALT muito maior que AST
- B) AST/ALT > 1,5 (AST desproporcionalmente elevada), em geral < 300 U/L
- C) Transaminases acima de 2000
- D) Bilirrubina normal
- E) INR sempre normal

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual vitamina deve ser administrada ANTES da glicose no etilista, para prevenir encefalopatia de Wernicke?

- A) Ácido fólico
- B) Tiamina (B1)
- C) Vitamina C
- D) Vitamina D
- E) Cianocobalamina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é uma contraindicação ABSOLUTA ao uso de corticoide na hepatite alcoólica grave?

- A) Ascite controlada
- B) Infecção ativa não controlada (ou sangramento digestivo ativo/sepses/IR grave/pancreatite)
- C) Icterícia
- D) Hepatomegalia
- E) AST elevada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual analgésico/antitérmico deve ser EVITADO na hepatite alcoólica aguda?

- A) Dipirona
- B) Paracetamol (e AINEs)
- C) Tiamina
- D) Lactulose
- E) Omeprazol

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Maddrey ≥ 32 define hepatite alcoólica grave; na ausência de contraindicações (infecção/sangramento/sepse/IR/pancreatite), indica-se prednisolona 40mg/dia por 28 dias, com reavaliação da resposta (escore de Lille).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A assinatura é AST/ALT $> 1,5$ (AST desproporcionalmente maior), com transaminases tipicamente abaixo de 300 U/L — diferente das hepatites virais/isquêmicas, que cursam com níveis muito mais altos.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A tiamina (B1) deve ser dada antes da glicose no etilista para prevenir a encefalopatia de Wernicke, pois a infusão de glicose sem tiamina pode precipitá-la.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Infecção ativa não controlada é contraindicação absoluta ao corticoide (assim como sangramento digestivo ativo, sepse, insuficiência renal grave e pancreatite aguda), pelo risco de agravar essas condições.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evita-se paracetamol (hepatotóxico, sobretudo no etilista/desnutrido) e AINEs (nefro/gastrolesivos no hepatopata). A dipirona é a opção preferida para dor/febre nesse contexto.

SM24
Suporte ao Plantão Médico